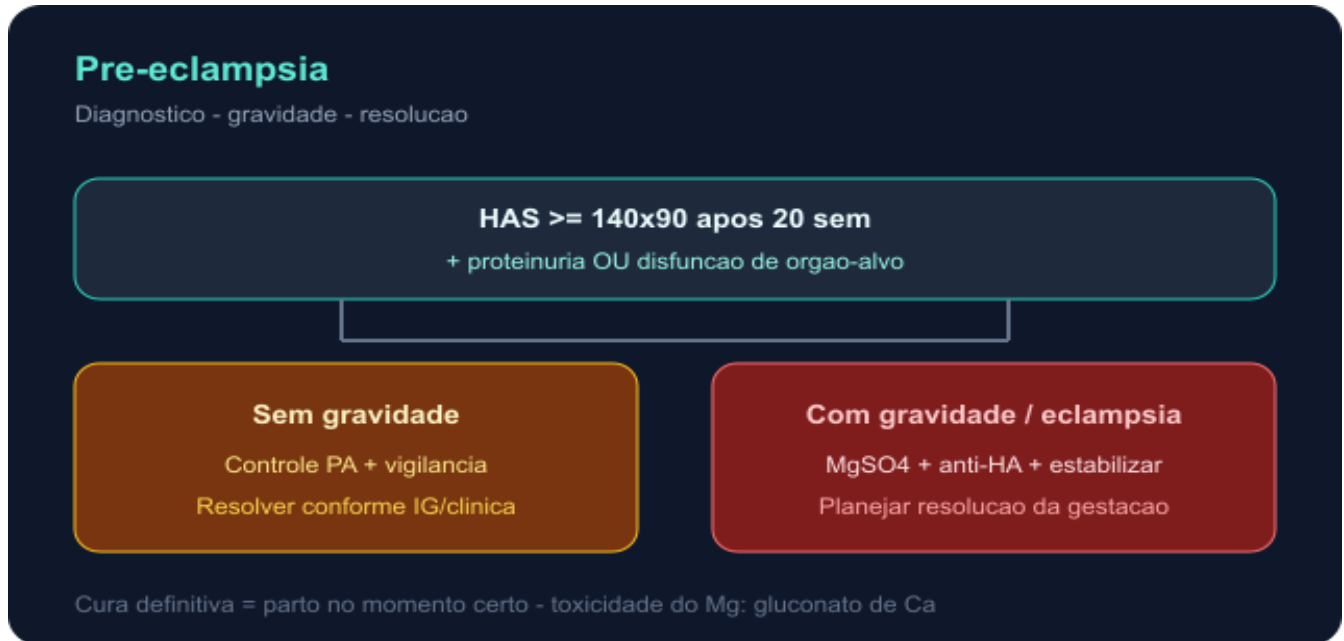


Pré-eclâmpsia · critérios e conduta

HAS gestacional + proteinúria ou disfunção de órgão-alvo após 20 semanas. Gravidade e idade gestacional guiam a resolução.

Mapa mental: diagnóstico !' gravidade !' conduta.



Diagnóstico (ideia central)

- PA $\geq$ 140x90 mmHg após 20 semanas em gestante previamente normotensa
- Associada a proteinúria (ex.: $\geq$ 300 mg/24 h ou relação proteína/creatinina $\geq$ 0,3) OU
- Sinais de disfunção de órgão-alvo mesmo sem proteinúria (PE com critérios de gravidade)

Critérios de gravidade (alto rendimento)

- PA $\geq$ 160x110 mmHg
- Plaquetopenia, elevação de enzimas hepáticas, creatinina elevada
- Edema pulmonar, cefaleia intensa / escotomas / epigastralgia
- Restrição de crescimento fetal / alterações de bem-estar fetal

Conduta em uma frase

Situação | Foco

PE sem gravidade, IG prematura | Controle pressórico + vigilância materna/fetal

PE com gravidade | Estabilizar, MgSO₄, anti-hipertensivo, planejar resolução

Eclâmpsia | ABC, MgSO₄, estabilizar e resolver a gestação

Cura definitiva | Resolução da gestação (parto) no momento adequado

MgSO₄

Dica - MgSO₄

Indicação clássica: prevenção/tratamento de convulsão na PE grave/eclâmpsia. Monitore reflexos, diurese e FR — toxicidade !' suspender e gluconato de cálcio.

Armadilha

Atenção - Armadilha

HAS crônica " PE. Em hipertensa crônica, suspeite de PE sobreposta se houver piora pressórica + proteinúria nova ou disfunção de órgão após 20 semanas.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.
www.medhubr1.com.br - MedHub R1